Processo nº **0026190-58.2023.8.17.2810**

AUTOR(A): L. R. D. S.

RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Vistos etc.

LEVI RAMOS DOS SANTOS, menor impúbere, neste ato representado por seu genitor, ROQUE DA COSTA RAMOS JUNIOR, por intermédio de advogado legalmente constituído, ajuizou a presente "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA INAUDITA ALTERA PARS C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS" em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, parte ré igualmente identificada.

Alegou a parte autora, em sua petição inicial, que:

A) nascido em 13/04/2010, atualmente com 13 anos de idade, não estava acompanhando o crescimento e estatura média das crianças da sua idade;

B) foi avaliado pela médica endocrinologista pediátrica Dra. Maria Paula Bandeira – CRM-PE 19.761, a qual emitiu parecer em 19 de maio de 2023, constatando que o segurado apresenta baixa velocidade de crescimento e avanço de idade óssea com piora de previsão de estatura final, bem abaixo do padrão populacional (CID-10: E23.0), sendo de extrema necessidade o uso do Hormônio do Crescimento Somatropina;

Pugnou pela tutela antecipada para determinar que forneça o medicamento indicado por laudo médico. Ao final, requereu a total procedência da demanda, com a confirmação da tutela e a condenação da ré ao pagamento de indenização dos danos morais ocasionados no importe de R$ 12.000,00.

Determinada a emenda à petição inicial, atribuiu à causa o valor de R$ 55.800,00. Promoveu o pagamento das custas processuais e da taxa judiciária.

Decisão de ID 137588810 indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Citada, a ré apresentou contestação (ID 147442055) na qual afirmou que não há obrigação legal para custeio de medicação, não sendo uma das hipóteses de tratamento na quimioterapia oncológica ou durante internação hospitalar. Requereu a total improcedência da demanda.

Réplica apresentada (ID 150552961).

Intimadas sobre a necessidade de produção de provas, apenas a parte ré apresentou manifestação, quando requereu o julgamento antecipado do litígio.

É o relatório necessário. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 330, I, do Código de Processo Civil, posto que se trata de matéria de direito e de fato, mas que dispensa a produção de prova em audiência, dado que as provas trazidas aos autos já são suficientes para o julgamento da causa.

Por inexistirem preliminares ou prejudiciais, passo, de imediato, ao mérito da demanda.

DO MÉRITO

Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela para fins de compelir a empresa demanda a arcar os custos da medicação SOMATROPINA. É fato incontroverso que a autora padece da doença indicada na inicial, bem como os riscos a que se submete.

Cinge-se a lide, unicamente, em verificar a eventual exclusão da cobertura em apólice e eventual existência de danos morais.

Da análise atenta dos autos, verifico que não assiste razão à parte demandante.

Explico.

Sobre o direito material específico em questão, a Lei nº 9.656/98 prevê expressamente a obrigatoriedade de cobertura das doenças listadas na “Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde”.

É o que se conclui da leitura de seu artigo 10, *caput* e §2º, que traz o chamado "plano-referência", de cobertura mínima devida a qualquer beneficiário do plano:

> "Art. 10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> § 2º *As pessoas jurídicas* que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei *oferecerão, obrigatoriamente*, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo *a todos os seus* atuais e *futuros consumidores.* (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001 c/c ADI 1931, STF)"

O plano-referência, de oferta mínima obrigatória por parte das operadoras de planos de saúde, portanto, ressalvadas hipóteses dos incisos do artigo 10, abarca todos os tratamentos das doenças elencadas com CID (Cadastro Internacional de Doenças).

Sendo assim, basta que a parte autora, vinculada ao plano de saúde, junte atestado de profissional da saúde habilitado a tanto demonstrando necessidade de tratamento de doença sofrida pelo consumidor para que tenha direito à cobertura do tratamento.

Portanto, a doença da qual padece o beneficiário do plano de saúde e o respectivo tratamento devem ser atestadas por profissional competente para tanto, de livre escolha do paciente, o que é assegurado pela própria lei 9.656/98 (art. 1º, I) e pela RN 428/ANS (art. 5º).

Especificamente sobre a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos por parte da operadora de plano de saúde, o já mencionado artigo 10 da Lei nº 9.656/98 põe a salvo situações específicas em seus incisos em que a cobertura não é obrigatória por força de lei, sem prejuízo de sua previsão contratual.

É o caso, por exemplo, do custeio de *alguns* tipos de medicamentos, cujo fornecimento não é obrigatório, salvo em casos de doenças específicas, como o câncer, ou que necessitem de administração ambulatorial, sendo que os medicamentos para usodoméstico e osimportados não

nacionalizados não são abrangidos pelo plano de referência, nos termos dos seguintes dispositivos da referida legislação:

> "Art. 10.É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
>
> V - *fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados*;
>
> VI - **fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;** (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> Art. 12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas
>
> I - quando incluir atendimento ambulatorial:
>
> c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência)
>
> II - quando incluir internação hospitalar:
>
> g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (...)

Desta feita, *a contrario sensu*, percebe-se que o fornecimento de medicamentos é devido, desde que não se trate de medicamentos importados nacionalizados nem os de uso para tratamento domiciliar, e, ainda, são devidos aqueles fármacos previstos no disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12 da lei 9.656/98, que visem tratamentos de câncer.

Em tempo, segundo a Resolução Normativa nº 167 da ANS, a definição de medicamento domiciliar é: “medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência e emergência)”.

No caso ora analisado, o medicamento cujo fornecimento foi pleiteado é de uso doméstico, foi juntado atestado médico confirmando que a autora possui doença, especificando a necessidade de tratamento mediante uso de medicamento, entretanto, a medicação é ministrada em seu domicílio.

Foi juntado laudo (ID 134619030), especificando que o autor apresenta baixa velocidade de crescimento e avanço de idade óssea com piora de previsão de estatura final, bem abaixo do padrão populacional (CID-10: E23.0). Indicou a utilização de uso do Hormônio do Crescimento Somatropina.

Ocorre que, no caso dos autos, o medicamento requerido pela parte autora não está previsto como exceção dentre as hipóteses legais previstas, não sendo o caso de administração ambulatorial e hospitalar, ou de medicação para o câncer.

Trata-se, portanto, de medicamento para tratamento domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, pois foi prescrito pelo médico assistente para ser autoadministrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente domiciliar em substituição ao atendimento ambulatorial ou hospitalar.

Nessa toada, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse

Desta feita, forçoso concluir pela ausência de cobertura contratual e legal para fornecimento deste medicamento. Nesse sentido, veja-se:

RECURSO ESPECIAL Nº 1959202 - CE (2021/0288107-2) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. CUSTEIO DO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. FÁRMACO DE AUTOADMINISTRAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. 1. Ação de obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento

Somatropina 15mg, prescrito para o tratamento da doença que acomete o beneficiário (baixa estatura idiopática). (...) Assim, reconhecida a natureza exemplificativa do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, passa-se a análise da questão relativa a obrigatoriedade de cobertura do medicamento pleiteado pelo beneficiário, qual seja, Somatropina 15mg. Segundo informa o laboratório detentor do registro do Norditropin (nome comercial da Somatropina) na bula do paciente registrada na Anvisa, o medicamento é apresentado em "solução injetável de somatropina - 1 sistema de aplicação preenchido descartável multidose que contém um carpule de 1,5 mL, vedado permanentemente em um sistema de aplicação de plástico. O botão de aplicação do sistema possui cor de acordo com a concentração: 5 mg/1,5 mL (laranja)" (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/250000015299065/). Trata-se, portanto, de medicamento para tratamento domiciliar a que alude o art. 10, VI, da Lei 9.656/1998, pois foi prescrito pelo médico assistente para ser auto administrado pelo paciente em seu domicílio, na medida em que seu uso não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado, tampouco se verifica ser a hipótese de o medicamento ser administrado em ambiente domiciliar em substituição ao atendimento ambulatorial ou hospitalar. Nessa toada, ambas as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)"(REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021). Logo, considerando que o fármaco requerido nos autos (Somatropina 15mg) não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998, forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde, diversamente do que decidiu o TJ/CE. Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, V, a, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso especial para julgar improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Em consequência, fica redistribuída a sucumbência, arcando a parte recorrida com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvada eventual concessão da gratuidade de justiça. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá? acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15. Publique-se.

Intimem-se. Brasília, 04 de outubro de 2021. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - REsp: 1959202 CE 2021/0288107-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/10/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SÁUDE PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA 1. Não há cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova na sentença quando a parte não demonstra o prejuízo na espécie, deixando de apontar os elementos probatórios que pretendia produzir. 2. Preliminar rejeitada. MÉRITO - PLANO DE SAÚDE - MENOR COM BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA - SOMATROPINA - MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL - FORNECIMENTO INDEVIDO 1. O plano de saúde não pode ser compelido a fornecer medicamento para tratamento domiciliar não incluído no rol da ANS e excluído do contrato com a operadora do plano de saúde, notadamente quando ausente prova técnica obtida sobre o crivo do contraditório quanto à excepcionalidade da situação. 2. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, quais sejam, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Jurisprudência do STJ. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50253372520228130024, Relator: Des.(a) Áurea Brasil, Data de Julgamento: 20/07/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

Em que pese nos solidarizarmos com a condição de saúde da parte autora e entender a necessidade de ver realizado o tratamento, não vislumbro a responsabilidade de a operadora de saúde arcar com os custos da medicação requestada.

Nesta ordem de ideias, a improcedência do pedido de custeio do tratamento é medida que se impõe e, considerando a inexistência de negativa indevida, de igual forma, deve ser improcedente os pleitos indenizatórios.

III - DISPOSITIVO

Desse modo, pelo que dos autos consta, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS da petição inicial e extingo o feito com resolução de mérito.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% do valor da causa.

Ademais, havendo interposição de apelação, em consonância com o art. 1.010 do CPC: (a) intime-se o recorrido para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar as devidas contrarrazões (§ 1º); (b) se o apelado interpuser apelação adesiva, intime-se o apelante para apresentar contrarrazões (§ 2º); (c) decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem a apresentação das contrarrazões, subam os autos ao Egrégio TJPE, com as homenagens deste Juízo (§ 3º).

POR FIM, CONSIDERANDO QUE A DECISÃO DO TJPE NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ENCONTRA-SE VIGENTE, A DESPEITO DA SENTENÇA ORA PROFERIDA EM SENTIDO DIVERSO, DEVE A RÉ OBSERVAR O SEU CUMPRIMENTO ATÉ QUE SE DELIBERE A RESPEITO DO RECEBIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA, A FIM DE EVITAR PREJUÍZOS AO AUTOR.

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Datado e assinado eletronicamente.

mmm

Assinado eletronicamente por: FABIANA MORAES SILVA
17/12/2023 10:59:25
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 155685176

23121710592537800000152072184

IMPRIMIR GERAR PDF